

Información Paciente

Nombre : Lidia Inés Garrido Ávila
Edad : 84a 2m 23d
Dirección : Loma De Sol 02840

Rut : 4.819.606-3
Fecha Nacto: 03/09/1938
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2214640
Sexo : Femenino
Teléfono : 968794405

N° Epicrisis
331572

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Geriatria
Unidad de Egreso : Geriatria

Fecha Ingreso : 11/11/2022 21:21
Fecha Egreso : 26/11/2022 09:11

Días Estadía: 15

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de consciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

INGRESO UNIDAD DE GERIATRÍA

Nombre: Lidia Garrido Avila
Edad: 84 años
RUT: 4819606-3
Dirección: Loma Del Sol 02840 (Puente Alto)
Consultorio de origen: Madre Teresa de Calcuta.
Teléfono tutor: 968794405
Fecha de Ingreso a CASR: 10/11/2022
Fecha de ingreso UGA: 12/11/2022
Persona que aporta datos: Monica (Hija)

BIOMÉDICOS

Antecedentes mórbidos: HTA, DM2NIR, ACV Isquemico Limitrofe Acm-Acp Izquierdo Estenosis Crítica De Arteria Carótida Interna Izquierda.
Antecedentes quirúrgicos: Endarterectomía Carotídea Izquierda

Alergias: No

Hábitos

Tabaco: No OH: no Drogas: no

Inmunizaciones: 4 Dosis (Covid-19), Influenza (+)

Nutricional: Sin cambios en su estado nutricional, apetito conservado.

Fármacos en uso: AAS 100mg c/24hrs, Atorvastatina 80 mg/d, Espironolactona 25 mg/24hrs, Amlodipino 10 mg/24hrs, Hidralazina 50 mg c/ 8h, Losartan 25mg c/24hrs, Levetiracetam 500 mg c/ 12 h, Quetiapina 25 mg/24hrs, omeprazol 20 mg/24hrs, Sulfato ferroso 200mg c/12hrs, Metformina 850mg c/24hrs.

Hospitalizaciones previas: Julio 2022 (ACV + Estenosis Crítica de Arteria Coronaria)

GERIATRICO

FUNCIONAL

Situación basal funcional, Paciente con dependencia leve en ABVD con Barthel 70/100 (posterior a ACV) Necesita ayuda

Fecha Epicrisis : 26/11/2022 09:48

Fecha Última Actualización: 26-11-2022 9:48:32

Página 2 de 5

trasladarse y subir escaleras, para aseo personal, Incontinencia urinaria de esfuerzo, Lawton 1/8 No Usa telefono, Dependiente para compras diarias, Comida, labores de casa, lavado de ropa, no es capaz de administrar su medicacion, ni manejar su dinero, Consultar por marcha, usa andador semi/movil, con antecedentes de caídas el último año # 2. Paciente con deterioro de su funcionalidad posterior a Accidente vascular isquémico en Julio 2022.

COGNITIVO/MENTAL

Escolaridad Medico completo, ocupación previa empresa de aseo, lectoescritura conservada, con historia de quejas de memoria referida por la familia y la paciente sin diagnóstico previo de demencia. Sin antecedentes de patología psiquiátrica previa, sin intentos suicidas, sin antecedentes de trastorno del ánimo ni uso previo de psicotrópicos, Insomnio de conciliación, con antecedentes de delirium en hospitalización anterior.

ANTECEDENTES SOCIALES

Viuda, tiene 4 hijos, vive con Mónica Martinez (Hija), Nieto, En una vivienda de 2 plantas, paciente vive en la 2da planta, cuenta con todos los servicios basicos. Con red presente y efectiva.

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Deterioro cognitivo (obs)

Demencia (obs)

Delirium (-)

Constipación (-)

Incontinencia/retención urinaria (+)

Trastorno del peso (-)

Sarcopenia (+)

Trastorno de la marcha y caídas (+)

Polifarmacia (+)

Trastorno del ánimo (obs)

Trastorno del sueño (+)

Fragilidad EVF 5/7

Déficit sensorial: Hipoacusia usuaria de Audifonos.

Úlceras por presión (-)

MOTIVO DE INGRESO: Compromiso de conciencia

Paciente con los antecedentes descritos, 10/11/22 Evolucionando con compromiso de conciencia, progresiva no súbita, de 5 minutos de duración, asociado a relajación de esfínter urinario y fecal, estridor laríngeo, con recuperación íntegra, sin focalidad, refiere que paciente recuerda lo acontecido, sin movimientos estereotipados, sin mordedura de lengua, sin angor, ni dolor torácico, es asistida por samu quienes describen estabilidad hemodinámica, ingresa a SU CASR, Hipertensa con PA: 180/81 FC 66x/min, T 36.1, Sat 97%, Evalúan dolor epigástrico tipo cólico asociado a 1 episodio diarreico autolimitado, afebril, HDN estable, Sin focalidad neurológica. evaluada por neurología imagen impresiona sin lesiones de carácter agudo. Dentro de los exámenes de laboratorio de ingreso destaca HipoNa: 127, Por lo que inician corrección.

Paciente Ingresa a UGA, Hemodinámicamente estable, Vigil, cooperadora.

EXAMEN FÍSICO

SV PA 123/59 FC 71x/min, T 36.0 Sat 96% amb.

Paciente Vigil, Cooperadora, Desorientada en Tiempo, Orientada en espacio y persona, con estado de atención fluctuante, no logra invertir series simples CAM (+).

Hemodinámicamente estable. VEC disminuido, Llene capilar 4 segundos, Mucosas Secas y palidas.

MP (+) SRA sin UMA, sin apremio ventilatorio ni requerimiento de O2

RR2T S/S

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, RHA (+)

EEII: Sin edema, sin signos de TVP, Pulsos periféricos presentes.

Neurológico: Obedece órdenes simples, nomenclatura y repite, sin disartria. Pupilas simétricas, isocoria, normoreactivas, Parecia leve en rama mandibular izquierda, fuerza muscular conservada, sensibilidad conservada. Sin focalidad neurológica.

EXÁMENES DE INGRESO:

Fecha Epicrisis : 26/11/2022 09:48

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 26-11-2022 9:48:32

Página 3 de 5

11/11/22: HTO/Hb: 36.2/12.2 Gb 10.650 RAL 7800 PQ 324.000, PCR 1.9, Crea 0.88 BUN 24.9, ELP 127/5.2/97 Ca: 11.3 Alb 4.2, Glicemia 106, FA 217 GGT 146, LDH 217, Lipasa 69, TUS <10, INR 1.09, (RECONTROL) ELP 129/4.6/102 Ca 10.0 Ca Corregido 9.8.
12/11/22: Crea 0.83 BUN 24.0 ELP 135/5.4/107, GSV: PH: 7.4 PCO2 36.8 HCO3 22.5.
SO: No Inflamatorio UC: Polimicrobiano.

TAC de Cerebro: Evaluado por Neurología en SU Descrito sin lesiones agudas, (Sin Informe).

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- 1- Compromiso de Conciencia Toxico-Metabolico
 - HipoNA Hipoosmolar (obs) VEC disminuido.
 - Síncope? 2° Hipersensibilidad del seno carotídeo (obs).
 - 2- Antecedentes HTA, DM2, ACV, T deglutorio Moderado.
- ### SÍNDROMES GERIÁTRICOS

FUNCIONAL

- Basal
- Dependencia Leve en ABVD, Dependencia Severa en AIVD (Barthel 70/100) (LW 1/8)

COGNITIVO/MENTAL

- Sospecha de deterioro cognitivo
- Sospecha de demencia

SOCIAL

Paciente con red social presente, efectiva, alta a domicilio.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS EN UNIDAD GERIÁTRICA DE AGUDOS

Cardio/HDN: Paciente con antecedentes de HTA, Ingresa normotensa, Normocardica, en contexto de compromiso de conciencia en estudio. Tiene Holter de Agosto tomado en contexto de estudio de fuente embólica de ACV, sin hallazgos relevantes, se solicita repetir Holter por evento agudo nuevo. Presenta soplo sistólico en foco aórtico irradiado a cuello, solicito ecocardiograma. Se realiza HolteR. Ecocardiograma fue desestimado por especialidad. Se mantiene autosustentada, se reinicia hidralazina con buena respuesta.

Neurologico: Paciente hospitalizada en Julio 2022 por ACV Isquemico ACM-ACP izquierdo + Estenosis Critica, en dicha oportunidad se realiza endarterectomía carotídea izquierda, con Dg al alta de Sd de Hiperfuncion por endarterectomía + Crisis Focal 2° Generalizada, es dada de alta con FAE, Se ha mantenido en controles por equipo de Neurología, ultimo control en Sept 2022: Solicitan EEG para retiro gradual de levetiracetam, Paciente a su ingreso se realiza TC de Cerebro. Descrito en SU (Evaluado por neurología imagen sin lesiones significativas) Sin informe. Por ahora mantengo FAE hasta evaluación Formal por neurología. Hora EEG se realizará 22/11/22 15:30hrs. 24/11 evaluada por equipo de neurología, quien sugiere: Dado EEG normal e interpretación de evento de crisis durante hospitalización anterior como reactiva a síndrome de hiperperfusión, se sugiere:

- Reducción progresiva de dosis de levetiracetam hasta suspender con el siguiente esquema:
 - 250mg-500mg por 1 semana
 - 250mg-250mg por 1 semana
 - 0-250mg por 1 semana y luego suspender
- Control ambulatorio por especialidad
- Dejo interconsulta

Renal/Medio Interno: A su ingreso se realiza paraclínicos que destaca Na: 127, Crea 0.88 BUN 24.9 Relacion BUN/Crea: 28.3, Osmolaridad Plasmática 268, VEC disminuido, inician corrección con SSF 0.9%, Logrando Corregir 10meq en 24hrs, Además destaca HiperCa 11.3 Sin alteraciones electrocardiográficas que normaliza posterior Fluidoterapia. Ingresa con ELP 135/5.4/107. Crea 0.83 BUN 24 (aun disociado) por lo que mantengo SRL 60ml/hora. Al recontrol ELP normales, vuelve a presentar hipercalcemia. Por lo anterior solicito estudio de neoplasias con TC TAP con contraste, marcadores tumorales y solicito niveles de PTH y calciuria para horario hábil. Durante el fin de semana con manejo con R. lactato. Al control con examen e n e s c on BUN 26. Pese a manejo persiste hipercalcemia. Obs déficit de vitamina D. Dada estabilidad de los niveles de Calcemia y ausencia de sintomatología se sugiere esperar evaluación de endocrinología.

Fecha Epicrisis : 26/11/2022 09:48

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:43

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Infeccioso: Delirium mixto en curso, se toma SO+UC, 23/11 SO inflamatorio +++, se inicia amikacina empírica 1 gr al día im por 4 días. En seguimiento

Metabólico: Actualmente con buen control de glicemia, sugiero mantener esquema correccional. 15/11 Hb A1c 5.4%. TSH 1.08 T4L 0.98

ETE: Paciente con Score PADUA 7, Con buena Fx renal, indico tromboprofilaxis con HBPM.

Endocrinología: Evaluada por equipo de endocrinología, quien sugiere: -Hipercalcemia dependiente de PTH, obs hiperparatiroidismo primario. Pendiente calciruria orina 24 hrs+crea en orina 24 hrs. Maxima calcemia 11.3, actualmente Ca 10.8 corregido. Mantener hidratación oral 1,5 lts de agua al día, no emplear tiazidas. Control ambulatorio en endocrinología para seguimiento y de forma ambulatoria completar estudio con DXA.

-Hipovitaminosis D: Se indica VIT D 1 cápsula a la semana, por 8 semanas y luego Calcio/Vitamina D 800 UI al día vo

Geriatrico/ Funcional: Paciente desde su ultima hospitalización mas dependiente en ABVD/AIVD, por relato dirigido de la tutora, Cuadro actual no es posible descartar Sincope, (p) PTO, Mantener KTM, Además con Dg al alta de Disfagia Fils 7, mantengo regimen papilla + líquidos espesante, alimentación asistida a 90°. hasta evaluación formal por FNA.

Cognitivo: Sin antecedentes previos de deterioro cognitivo pero con queja de memoria, evaluación por equipo multidisciplinario.

Social: Con red presente y efectiva alta a domicilio.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

BIOMÉDICO

1- ITU KPN BLEE tratada

2- Compromiso de Conciencia Toxico-Metabólico

·HipoNA Hipoosmolar (obs) VEC disminuido.

·Sincope? Obs 2° Hipersensibilidad del seno carotídeo

3- Hipercalcemia en estudio

·Obs Hiperparatiroidismo primario v/s Déficit de Vitamina D

4- Antecedentes, HTA, DM2, ACV, T deglutorio Moderado.

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

FUNCIONAL

Basal

·Dependencia Leve en ABVD, Dependencia Severa en AIVD (Barthel 70/100) (LW 1/8)

COGNITIVO/MENTAL

·Sospecha de deterioro cognitivo

·Sospecha de demencia

SOCIAL

Paciente con red social presente, efectiva, alta a domicilio.

Diagnóstico de Egreso

HIPOSMOLARIDAD E HIPONATREMIA -

HIPERPARATIROIDISMO Y OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA PARATIROIDES - en estudio

DELIRIO SUPERPUESTO A UN CUADRO DE DEMENCIA - tóxico-metabólico resuelto

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

estable en lo hemodinámico, neurológico e infeccioso.

en condiciones de traslado en ambulancia a su domicilio

Plan Post Alta

- Reposo relativo, levantar diariamente y realizar actividades de vida diaria

Fecha Epicrisis : 26/11/2022 09:48

Fecha Última Actualización: 26-11-2022 9:48:32

Página 5 de 5

- Régimen blando, sin granos hiposódico, diabético y líquidos claros (con bombilla)
- Ac. Acetil salicílico 100 mg, 1 comprimido al día vo
- Atorvastatina 20 mg, 2 comprimidos en la noche vo
- Levetiracetam 500 mg, 1 comprimido c/12 hrs
- Reducción progresiva de dosis de levetiracetam hasta suspender con el siguiente esquema: Desde lunes 28/11/22
 - 250mg-500mg por 1 semana (1/2 comp am y 1 comp pm)
 - 250mg-250mg por 1 semana (1/2 comp am y 1/2 com pm)
 - 0-250mg por 1 semana y luego suspender (sólo 1/2 comp pm)
- Quetiapina 25 mg, 1 y 1/2 comprimido en la noche vo
- Hidralazina 50 mg, 1 comprimido cada 8 horas vo
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos c/8 horas vo
- Vitamina D 50.000 UI, 1 cápsula a la semana por 8 semanas, luego Vitamina D 800 U 1 comprimido al día vo
- Control en CDT neurología (dejo IC para tomar hora)

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

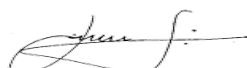
Régimen Alimentario : Blando

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Bec. Camila Stefany Diaz Jacob
Médico Tratante (Staff)